Клинические рекомендации

Абсцесс, фурункул и карбункул носа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J34.0** — Абсцесс, фурункул и карбункул носа
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.10.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/956_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология 3

2.3 Патогенез 4

2.4 Классификация 4

2.5 Клиническая картина 4

2.6 Анамнез 4

3. Диагностика 5

3.1 Физикальное обследование 5

3.2 Признаки внутричерепных осложнений 5

3.3 Лабораторные исследования 6

4. Лечение 6

4.1 Местное лечение 7

4.2 Анальгетическая и противовоспалительная терапия 7

4.3 Анальгетическая терапия у взрослых 7

4.4 Анальгетическая терапия у детей 8

4.5 Системная антибактериальная терапия 9

4.6 Парентеральные антибактериальные препараты 9

4.7 Антикоагулянтная терапия 10

4.8 Хирургическое лечение 10

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 11

5.1 Рецидивирующее течение 11

5.2 Профилактика 11

5.3 Показания к госпитализации 11

6. Источник и актуальность **12**

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 12

1. Основные положения

- В стадии инфильтрации лечение фурункула консервативное; при абсцедировании и при карбункуле гнойник вскрывают и дренируют, не прекращая консервативной терапии.
- При фурункуле, карбункуле и абсцессе носа во всех случаях необходима системная антибактериальная терапия, направленная на санацию очага инфекции и профилактику осложнений.
- При каждом осмотре необходимо исключить признаки внутричерепных осложнений: синдром системной воспалительной реакции, неврологическую и офтальмологическую симптоматику, тромбоз угловой вены и кавернозного синуса.
- Лихорадка, головная боль, хемоз, экзофтальм и поражение III, IV, V и VI пар черепных нервов свидетельствуют о возможном тромбозе кавернозного синуса; в этом случае требуется компьютерная томография (КТ) головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием.
- Дети с данным диагнозом во всех случаях подлежат госпитализации в круглосуточный оториноларингологический стационар; взрослые в стадии инфильтрации могут получать лечение амбулаторно.
- Массаж области носа и выдавливание содержимого фурункула противопоказаны.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Фурункул носа представляет собой острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и сальной железы, локализующееся на кончике или крыльях носа, в преддверии носа или в области дна носа у верхней губы. Карбункул носа характеризуется гнойно-некротическим воспалением нескольких волосяных фолликулов и сальных желёз с распространением процесса вглубь тканей и по поверхности, с обширными некрозами кожи и подкожной клетчатки. Абсцесс носа (абсцедирующий фурункул) представляет собой скопление гноя, возникающее при острой инфекции и приводящее к деструкции тканей в очаге, часто с перифокальным отёком.

2.2 Этиология

Ведущим возбудителем является золотистый стафилококк; резервуаром инфекции служат бессимптомные носители. Возбудителями пиодермии и фурункула носа могут быть также стрептококки, прежде всего бета-гемолитический стрептококк группы А. Инфицированию волосяного фолликула способствуют микротравмы кожи носа и его преддверия, загрязнение кожи техническими маслами и пылью при несоблюдении гигиены, а также переохлаждение, перегревание, стресс и нарушение секреторной функции кожи. У детей фурункул носа в большинстве случаев возникает вследствие привычки ковырять в носу и чрезмерного сморкания.

Фурункул носа нередко является проявлением фурункулёза, то есть образования множественных фурункулов на фоне вторичного иммунодефицита при эндокринных заболеваниях, прежде всего при сахарном диабете, а также при гиповитаминозе, нарушениях питания и заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

2.3 Патогенез

Отток венозной крови от средней зоны лица (так называемого опасного треугольника, ограниченного линиями, соединяющими назион с углами рта) осуществляется по угловым венам, венам орбиты и крыловидному сплетению в кавернозный синус. Вены этой системы лишены клапанов, поэтому инфекция с кожи лица, носа и околоносовых пазух может распространяться гематогенным путём в глазницу, далее в кавернозный синус и на головной мозг. В кавернозном синусе проходят внутренняя сонная артерия, III, IV и VI пары черепных нервов, первая и вторая ветви тройничного нерва; к нему прилежат гипофиз и клиновидная пазуха. Этими анатомическими особенностями обусловлена тяжесть внутричерепных осложнений.

При снижении сопротивляемости организма и высокой вирулентности возбудителя возможна генерализация процесса: стафилококки распространяются в окружающие ткани или проникают в кровоток с развитием сепсиса. В зоне инфильтрата развивается тромбоз мелких вен, и увеличение воспалительного очага повышает угрозу распространения тромбоза.

2.4 Классификация

По стадии воспалительного процесса выделяют I стадию (инфильтрации) и II стадию (абсцедирования).

2.5 Клиническая картина

Пациенты с фурункулом носа предъявляют жалобы на боль в области носа, головную боль, слабость, снижение работоспособности, повышение температуры тела до субфебрильных значений. В общем анализе крови возможны сдвиг лейкоцитарной формулы влево и повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Фурункул может локализоваться на кончике носа, в преддверии носа, вблизи перегородки носа или в области дна носа.

В стадии инфильтрации отмечаются постепенно нарастающая гиперемия кожи над фурункулом, локальная боль, усиливающаяся при мимических движениях и жевании, нарастающая инфильтрация мягких тканей. Вокруг первичного очага образуется некротическая ткань, формируется стержень фурункула. На внутренней поверхности входа в нос определяется болезненный конусовидный инфильтрат.

При благополучном течении происходит отторжение некротического стержня с выделением небольшого количества гноя, инфильтрат уменьшается, болевой синдром регрессирует, температура тела нормализуется, общее состояние улучшается.

В стадии абсцедирования при прогрессировании процесса зона некроза увеличивается, кожа над инфильтратом истончается, появляется флюктуация, формируется абсцесс.

Для карбункула и абсцесса носа характерны тяжёлое общее состояние, фебрильная лихорадка, ощущение распирания и выраженная пульсирующая боль. В области носа появляются несколько плотных инфильтратов, которые сливаются в единый увеличивающийся очаг. В области карбункула формируется обширная полость с гнойно-некротическим содержимым, на коже образуется несколько отверстий, из которых выделяются гной и некротизированные кровянистые массы.

У детей заболевание протекает тяжелее вследствие выраженного интоксикационного синдрома (головная боль, слабость, вялость, лихорадка). Местные изменения могут развиваться стремительнее, а обширный отёк и гиперемия верхней губы или щёчной области могут маскировать фурункул под заболевание челюстно-лицевой области.

2.6 Анамнез

В анамнезе возможны указания на переохлаждение и косметические процедуры в области наружного носа и его преддверия.

3. Диагностика

Диагноз фурункула носа устанавливается на основании трёх критериев: жалоб, данных осмотра и передней риноскопии. Пациенты предъявляют жалобы на выраженную боль в области очага, усиливающуюся при прикосновении, головную боль, недомогание, повышение температуры тела. При осмотре определяются гиперемия, отёк и инфильтрация мягких тканей наружного носа, преддверия носа и носо-лицевой области, резкая болезненность при пальпации. При передней риноскопии в преддверии носа у волосяного фолликула выявляются гиперемия кожи, инфильтрат и гнойный стержень в центре.

3.1 Физикальное обследование

Каждый пациент с подозрением на фурункул носа для установления и уточнения диагноза подлежит первичному осмотру врачом-оториноларингологом, врачом общей практики или педиатром.

При передней риноскопии на начальном этапе может определяться остиофолликулит преддверия носа: гиперемия и уплотнение в устье волосяного фолликула. В течение 1–2 суток развиваются отёк, инфильтрация и гиперемия кожи входа в нос (стадия инфильтрации), затем кожа истончается, происходит гнойно-некротическое расплавление тканей в очаге с образованием детрита. При наружном осмотре определяются гиперемия, отёк и болезненность в области преддверия и кончика носа; прикосновение к носу и риноскопия болезненны. Кожа преддверия носа может быть покрыта толстыми жёлтыми корками. При выраженном воспалении отёк распространяется на щёчную область и верхнюю губу.

Основным методом инструментальной диагностики является передняя риноскопия; её выполняют у всех пациентов, чтобы осмотреть полость носа и уточнить локализацию фурункула.

3.2 Признаки внутричерепных осложнений

При каждом осмотре необходимо оценивать наличие симптомов внутричерепных осложнений, которые объединяются в три синдрома: инфекционный, неврологический и офтальмологический.

Инфекционный синдром представляет собой синдром системной воспалительной реакции: температура тела 38 °C и выше или 36 °C и ниже, частота сердечных сокращений 90 в минуту и более, частота дыхания более 20 в минуту, количество лейкоцитов более 12×10^9/л или менее 4×10^9/л либо незрелых форм более 10%, уровень прокальцитонина в плазме 0,5 нг/мл и выше.

Неврологический синдром включает интенсивную головную боль, тошноту и рвоту, не связанные с приёмом пищи, несистемное головокружение. О развитии менингеального синдрома свидетельствуют светобоязнь, звукобоязнь, гиперестезия кожи, ригидность затылочных мышц; могут определяться симптомы Кернига и Брудзинского, скуловой симптом Бехтерева, симптом Менделя. При прогрессировании возможны оглушение, психомоторное возбуждение, судорожный синдром.

Офтальмологический синдром включает отёк век, хемоз и экзофтальм на стороне поражения; при пальпации век могут определяться болезненные тромбированные вены. При офтальмоскопии возможно выявление признаков внутричерепной гипертензии.

Для тромбоза угловой вены характерны резкая болезненность при пальпации, интенсивная головная боль, отёк лица на стороне поражения; угловая вена пальпируется в виде плотного болезненного тяжа.

Для тромбоза кавернозного синуса, особенно на начальном этапе, характерен выраженный цианоз слизистой оболочки губ, кожи лба и носа. В дальнейшем нарастает отёк верхней губы и щеки на стороне поражения с распространением на височную и лобную области, веки и противоположную половину лица. Развивается нарушение функции глазодвигательного, блокового, отводящего и тройничного нервов вплоть до полного её выпадения.

Подозрение на тромбоз кавернозного синуса служит показанием к компьютерной томографии (КТ) головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием.

О возможном тромбозе кавернозного синуса свидетельствуют фебрильная лихорадка, головная боль, хемоз, экзофтальм и признаки поражения III, IV, V и VI пар черепных нервов.

При осложнённом течении необходимы первичные консультации офтальмолога и невролога для дифференциальной диагностики и выбора тактики лечения.

При распространении воспалительного процесса на область лица целесообразна консультация челюстно-лицевого хирурга.

Алгоритм ведения пациента (приложение Б) при внутричерепных осложнениях предусматривает консультации нейрохирурга, офтальмолога и челюстно-лицевого хирурга.

> Состав консультантов при осложнениях в разных разделах рекомендации не совпадает: в разделе 2.5 и в критериях качества указаны невролог и офтальмолог, в алгоритме (приложение Б) указаны нейрохирург, офтальмолог и челюстно-лицевой хирург.

3.3 Лабораторные исследования

Развёрнутый общий анализ крови обязателен для всех пациентов на любой стадии заболевания: он позволяет оценить общее состояние и выраженность воспалительного процесса.

Биохимический анализ крови выполняют для выявления сахарного диабета, нарушений углеводного обмена и других состояний, способствующих развитию фурункула и утяжеляющих его течение.

Сахарный диабет неблагоприятно влияет на частоту развития, течение и прогноз фурункула. При повышенном уровне глюкозы пациента направляют к эндокринологу для коррекции гликемии, выявления сахарного диабета и назначения лечебного питания. Изменения уровня билирубина, креатинина, мочевины, активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) свидетельствуют о нарушении функции печени и почек.

У всех пациентов с осложнённым течением фурункула носа и с сопутствующими заболеваниями оценивают коагулограмму.

При абсцедирующем фурункуле, карбункуле и абсцессе носа гнойное отделяемое направляется на посев на аэробную и факультативно-анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам для обоснованного выбора антибактериального препарата.

Материал забирают из раны после вскрытия, без контакта с окружающими тканями, до начала антибактериальной терапии.

---

4. Лечение

Метод лечения определяется стадией фурункула и характером проявлений, в том числе наличием карбункула или абсцесса. При неосложнённом течении лечение преимущественно консервативное, местное и парентеральное. Лечение носит комплексный характер и направлено на элиминацию возбудителя, купирование интоксикации, восстановление обмена веществ и повышение защитных сил организма.

По алгоритму ведения пациента (приложение Б) в стадии инфильтрации лечение консервативное, в стадии абсцедирования хирургическое в сочетании с консервативным. В стадии разрешения предусмотрена консультация физиотерапевта, при рецидиве консультации эндокринолога и аллерголога-иммунолога.

4.1 Местное лечение

Для подавления инфекции и воспаления у всех пациентов с фурункулом носа местно применяют антисептики.

В первые часы после появления инфильтрата эффективно повторное смазывание пустулы 5% спиртовым раствором йода. Выраженным действием обладают четвертичные аммониевые соединения (бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний), препараты йода (повидон-йод разрешён детям старше 28 дней) и хлоргексидин; эти средства допустимо использовать у взрослых и детей. Кратность обработки раны зависит от выраженности воспаления; рану обрабатывают до разрешения инфекционного процесса. В стадии инфильтрации кожа вокруг очага бережно обрабатывается 70% этанолом.

При фурункуле и карбункуле носа для санации очага местно используют мази с антибиотиками широкого спектра действия.

Мупироцин в форме мази наносится взрослым 2–3 раза в день в течение 5–7 дней, детям с рождения 2–3 раза в день не более 10 дней. Фузидовая кислота в форме мази или крема наносится взрослым на кожу над фурункулом до 3–4 раз в день в течение 7–14 дней, детям с рождения в форме крема 3–4 раза в день в течение 7–14 дней. Мазь диоксометилтетрагидропиримидин + хлорамфеникол обладает противомикробным и противовоспалительным действием; взрослым и детям с одного года она наносится один раз в день до очищения раны от гнойно-некротических масс.

4.2 Анальгетическая и противовоспалительная терапия

Для купирования воспаления и болевого синдрома при отсутствии противопоказаний рекомендуется противовоспалительная и обезболивающая терапия.

Используют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и другие анальгетики-антипиретики в монотерапии или в комбинации. Выраженный лечебный эффект оказывает сочетание НПВП с парацетамолом, а для купирования болевого синдрома у взрослых и детей, в том числе в послеоперационном периоде, применяется метамизол натрия. Из НПВП у детей допускается применение ибупрофена с 3 месяцев, кетопрофена с 15 лет, кетопрофена в форме гранул для приготовления раствора для приёма внутрь с 6 лет.
В амбулаторной практике от назначения метамизола натрия детям следует воздержаться; в стационаре препарат применяется только при отсутствии других анальгетиков, разрешённых к применению у детей, в связи с риском серьёзных нежелательных явлений.

4.3 Анальгетическая терапия у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол	0,5–1 г внутривенно, инфузия в течение 15 минут	6 ч	4 г	5–7 суток
Диклофенак	75 «мл» внутримышечно (так в таблице рекомендации; по смыслу 75 мг)	12 ч	150 мг	2 суток
Кеторолак	30 мг внутривенно или внутримышечно	8 ч	60–90 мг	2 суток
Кетопрофен	100 мг внутривенно или внутримышечно	12 ч	200 мг	не более 2 суток
Лорноксикам	8 мг внутривенно или внутримышечно	12 ч	16 мг	1–7 суток
Декскетопрофен	50 мг внутривенно или внутримышечно	8–12 ч	150 мг	2 суток
Метамизол натрия	500–1000 мг внутривенно или внутримышечно	8–12 ч	2 г	1–5 суток

Разовая доза диклофенака в таблице 1 указана как «75 мл в/м»; исходя из смысла и суточного максимума 150 мг, речь идёт о 75 мг.

4.4 Анальгетическая терапия у детей

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол внутривенно	Инфузия в течение 15 минут: менее 10 кг — 7,5 мг/кг; 10–50 кг — 15 мг/кг; более 50 кг — 1000 мг	4 ч	Менее 10 кг — менее 30 мг/кг; 10–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 2 г; 33–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 3 г; более 50 кг — 4 г	5–7 суток
Парацетамол внутрь	С 12 лет — 0,5–1 г; 6–12 лет — 240–480 мг; 1–6 лет — 120–240 мг; от 3 месяцев до года — 72–120 мг	6 ч	С 12 лет — 4 г; 33–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 3 г; 10–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 2 г; менее 10 кг — менее 30 мг/кг	С 12 лет — 3 суток, до 12 лет — 5–7 суток
Парацетамол в ректальных суппозиториях	10–14 лет — 500 мг; 5–9 лет — 250 мг; 1–4 года — 100 мг; 3–12 месяцев — 50–100 мг	4–6 ч	Менее 60 мг/кг	До 5 суток
Ибупрофен внутрь	Старше 6 лет — 200–400 мг; 4–6 лет — 150 мг; 1–3 года — 100 мг; 3–12 месяцев — 50 мг	8 ч	12–17 лет — 1 г; 6–12 лет — 800 мг; 4–6 лет — 450 мг; 1–3 года — 300 мг; 6–12 месяцев — 200 мг; 3–6 месяцев — 150 мг	4 суток
Ибупрофен в ректальных суппозиториях	3–9 месяцев — 60 мг; 9–24 месяца — 60 мг	8 ч (3–9 месяцев), 6 ч (9–24 месяца)	3–9 месяцев — 180 мг; 9–24 месяца — 240 мг	Не более 3 суток
Кетопрофен	С 15 лет — 100 мг внутривенно или внутримышечно	12 ч	200 мг	Не более 2 суток
Кетопрофен в гранулах для раствора внутрь	Старше 6 лет — 40 мг	8 ч	120 мг	Не более 2 суток
Метамизол натрия внутримышечно	13–14 лет — 0,8–1,8 мл (400–900 мг); 10–12 лет — 0,5–1,0 мл (250–500 мг); 7–9 лет — 0,4–1,0 мл (200–500 мг); 4–6 лет — 0,3–0,8 мл (150–400 мг); 1–3 года — 0,2–0,5 мл; 3–11 месяцев — 0,1–0,2 мл (50–100 мг)	8–12 ч	С 15 лет — 2 г; 8–14 лет — 900 мг; 4–7 лет — 600 мг; 2–3 года — 300 мг	1–5 суток

> В строке метамизола натрия таблицы 2 для детей 1–3 лет указано «0,2–0,5 мл (100–2500 мг)». При концентрации 500 мг в 1 мл, как и в соседних строках, 0,5 мл соответствуют 250 мг, следовательно, значение «2500» является опечаткой. Возраст «79 лет» в той же строке следует читать как 7–9 лет.

4.5 Системная антибактериальная терапия

Всем пациентам с фурункулом, карбункулом и абсцессом носа для санации очага инфекции и предупреждения осложнений проводят системную антибактериальную терапию.

Внутрь взрослым и детям старше 12 лет или с массой тела более 40 кг применяют амоксициллин с клавулановой кислотой по 1000 мг (875/125) 2 раза в сутки в течение 7 дней. Для детей от 3 месяцев до 12 лет с массой тела менее 40 кг предусмотрена форма суспензии (400 мг амоксициллина + 57 мг клавулановой кислоты в 5 мл) из расчёта 20 мг/кг в сутки, новорождённым и детям до 3 месяцев — 30 мг/кг (по амоксициллину) 2 раза в день, 7–14 дней. С 12 лет возможно применение цефдиторена по 200 мг каждые 12 часов в течение 10 дней.

При тяжёлом или рецидивирующем течении фурункула и при непереносимости бета-лактамных антибиотиков пациентам с 18 лет могут быть назначены левофлоксацин по 750 мг один раз в сутки в течение 7–14 дней или моксифлоксацин по 400 мг один раз в сутки в течение 7 дней.

Препаратом первой линии для парентерального введения является цефазолин: взрослым по 0,5 г внутривенно или внутримышечно 2 раза в день, детям от месяца до 18 лет — 20–50 мг/кг в сутки в 3–4 введения, в течение 7–10 дней. Цефтриаксон вводится взрослым и детям старше 12 лет или с массой тела более 50 кг по 1–2 г один раз в сутки; новорождённым до 14 дней — 20–50 мг/кг один раз в сутки, не более 50 мг/кг; детям от 15 дней до 12 лет — 20–80 мг/кг один раз в сутки, в течение 7–10 дней.

Ампициллин с сульбактамом вводится внутримышечно или внутривенно (капельно со скоростью 60–80 капель в минуту или струйно медленно в течение 3–5 минут): взрослым 3–12 г в сутки в 3–4 введения в зависимости от тяжести инфекции, детям 150 мг/кг в сутки в 3–4 введения, недоношенным и детям первой недели жизни — 75 мг/кг в сутки в 2 введения, в течение 5–14 дней. Амоксициллин с клавулановой кислотой внутривенно вводится взрослым и детям старше 12 лет по 1 г (по амоксициллину) 3 раза в сутки; детям до 3 месяцев и с массой тела менее 4 кг — 25/5 мг/кг каждые 8 часов, только медленной инфузией в течение 30–40 минут; от 3 месяцев до 12 лет — 25/5 мг/кг каждые 6–8 часов в зависимости от тяжести инфекции, в течение 5–14 дней.

При аллергии на бета-лактамные антибиотики применяют клиндамицин: взрослым парентерально 0,6–2,7 г в сутки в несколько введений, детям 3–18 лет — 20–40 мг/кг в сутки в 3–4 равных приёма, в течение 7–10 дней. Детям младше 3 лет препарат противопоказан.

4.6 Парентеральные антибактериальные препараты

Препарат	Разовая доза	Кратность	Максимум в сутки	Длительность
Цефазолин	Взрослым 0,5 г; детям старше месяца 10–20 мг/кг; внутривенно или внутримышечно	2 раза в сутки	Взрослым 6 г, детям старше месяца 100 мг/кг	7–10 дней
Цефтриаксон	Взрослым 1–2 г; новорождённым до 14 дней 20–50 мг/кг; детям от 15 дней до 12 лет 20–80 мг/кг; внутривенно или внутримышечно	1 раз в сутки	Взрослым 4 г, детям 2 г	7–10 дней

Препарат	Разовая доза	Кратность	Максимум в сутки	Длительность
Ампициллин + сульбактам	Взрослым 1–2 г; детям старше месяца 50 мг/кг; новорождённым до 14 дней 75 мг/кг; внутривенно или внутримышечно	Взрослым и детям старше месяца 3 раза, новорождённым 2 раза в сутки	Взрослым 6 г, детям 150 мг/кг	5–14 дней внутримышечно (или 5–7 дней внутривенно, затем внутримышечно до 14 дней)
Амоксициллин + клавулановая кислота	Взрослым и детям старше 12 лет 1 г внутривенно; до 12 лет 25 мг/кг внутривенно	Взрослым и детям старше 3 месяцев 3 раза, детям до 3 месяцев 2–3 раза в сутки	Взрослым и детям старше 12 лет 6 г, до 12 лет 50–75 мг/кг	5–14 дней
Клиндамицин	Взрослым «0,2–0,9 мг» (так в таблице; внутримышечно не более 0,6 г, внутривенно не более 1,2 г на одно введение); детям 3–18 лет 5–10 мг/кг внутримышечно или внутривенно	3–4 раза в сутки	Взрослым 4,8 г, детям 40 мг/кг	7–10 дней

> Данные раздела 3.1 и таблицы 3 не совпадают. Цефазолин детям: в тексте 20–50 мг/кг в сутки в 3–4 введения, в таблице 10–20 мг/кг 2 раза в сутки. Ампициллин с сульбактамом: в тексте взрослым до 12 г в сутки, в таблице максимальная доза 6 г; новорождённым в тексте 75 мг/кг в сутки в 2 введения, в таблице 75 мг/кг на введение 2 раза в сутки. Амоксициллин с клавулановой кислотой детям: в тексте 25 мг/кг каждые 6–8 часов (до 100 мг/кг в сутки), в таблице максимальная доза 50–75 мг/кг в сутки. Разовая доза клиндамицина взрослым в таблице указана в миллиграммах («0,2–0,9 мг»), хотя, исходя из смысла и текста (0,6–2,7 г в сутки), речь идёт о граммах.

4.7 Антикоагулянтная терапия

Осложнённое течение фурункула, карбункула или абсцесса носа во всех случаях требует профилактики тромбозов антикоагулянтами прямого или непрямого действия.

Доза подбирается под контролем показателей свёртывающей системы крови.

4.8 Хирургическое лечение

Хирургическое лечение фурункула носа показано только в стадии абсцедирования, а также при карбункуле носа.

При осложнённом течении абсцесс или карбункул носа вскрывают, чтобы эвакуировать гной и обеспечить дренирование.

Вмешательство возможно как под местной анестезией, так и под общим обезболиванием. Забор материала из раны для бактериологического исследования обязателен.

В стадии разрешения для ускорения выздоровления показана консультация физиотерапевта.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Рецидивирующее течение

При рецидивирующих фурункулах носа рекомендована консультация эндокринолога (у детей детского эндокринолога) для выявления причины рецидивов.

В ряде случаев целесообразна также консультация аллерголога-иммунолога.

Для профилактики рецидивов при рецидивирующем течении фурункула носа применяют бактериофаги.

Местное применение бактериофагов в комплексном лечении оправдано при устойчивости выделенных штаммов к антибиотикам, при наличии в анамнезе более двух курсов антибактериальной терапии, при непереносимости антибиотиков и при рецидивирующем течении.

5.2 Профилактика

Основой профилактики фурункула и его осложнений является соблюдение личной гигиены: мытьё рук до и после еды, после посещения туалета, поездок в транспорте и посещения общественных мест. Важное значение имеет также гигиена труда, в том числе использование средств защиты при работе в условиях запылённости и загрязнения. Не допускаются прикосновения к коже лица, особенно носа, грязными руками, массаж болезненных участков, выдавливание фурункула и самолечение. При сахарном диабете и других сопутствующих заболеваниях необходимы соблюдение диеты и своевременный приём лекарственных препаратов. Гигиеническим навыкам обучают в семье, детском саду и школе.

Пациенту разъясняется необходимость осторожного отношения к косметическому уходу за лицом, включая чистку лица и бритьё; при появлении гнойничка на коже носа или верхней губы массаж и выдавливание его категорически противопоказаны. Родителям следует контролировать чистоту рук ребёнка, обучать его правильному туалету носа и не допускать ковыряния в носу. При появлении отёка или гиперемии в области фурункула пациенту рекомендуется обращаться в оториноларингологический стационар.

5.3 Показания к госпитализации

У детей установленный диагноз абсцесса, фурункула или карбункула носа является показанием к госпитализации в круглосуточный оториноларингологический стационар. Взрослые в стадии инфильтрации могут получать лечение у оториноларинголога амбулаторно. Пациенты с фурункулом в стадии инфильтрации и сопутствующими заболеваниями, а также пациенты с рецидивирующими фурункулами упоминаются в рекомендации отдельно, однако тактика их ведения не указана. В большинстве случаев пациентов ведёт оториноларинголог в условиях хирургического стационара.

> В разделе 6 фраза о пациентах с сопутствующими заболеваниями и рецидивирующими фурункулами не закончена и тактика их ведения не указана; по контексту, по-видимому, подразумевается госпитализация. Кроме того, в информации для пациента (приложение В) при отёке или гиперемии в области фурункула всем пациентам рекомендуется обращаться в оториноларингологический стационар, хотя гиперемия и отёк отмечаются уже в стадии инфильтрации, при которой взрослые, согласно разделу 6, могут получать лечение амбулаторно.

Пациента выписывают при положительной динамике и отсутствии осложнений: после разрешения абсцесса, фурункула или карбункула, при удовлетворительном общем состоянии и нормализации температуры тела.

При неосложнённом течении прогноз благоприятный. У пациентов с первичным или вторичным иммунодефицитом и с сахарным диабетом следует ожидать более тяжёлого течения и высокого риска осложнений.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Абсцесс. Фурункул носа. Карбункул носа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 14.10.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2028 года
Код в рубрикаторе	956_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В таблице 1 разовая доза диклофенака указана как «75 мл».
- В таблице 2 для метамизола натрия у детей 1–3 лет указано «100–2500 мг» (объёму 0,2–0,5 мл соответствуют 100–250 мг), а возраст «79 лет» означает 7–9 лет.
- Дозы антибактериальных препаратов в тексте раздела 3.1 и в таблице 3 не совпадают: доза цефазолина у детей, максимальная доза ампициллина с сульбактамом у взрослых и его доза у новорождённых, суточная доза амоксициллина с клавулановой кислотой у детей.
- Разовая доза клиндамицина взрослым в таблице 3 указана как «0,2–0,9 мг» вместо граммов; в тексте фраза «противопоказан детям в возрасте старше до 3-х лет» искажена (по контексту имеется в виду возраст младше 3 лет).
- Состав консультантов при внутричерепных осложнениях в разделе 2.5 и в критериях качества (невролог, офтальмолог) не совпадает с алгоритмом в приложении Б (нейрохирург, офтальмолог, челюстно-лицевой хирург).
- В разделе 6 фраза о пациентах с сопутствующими заболеваниями и рецидивирующими фурункулами не закончена; рекомендация из приложения В обращаться в стационар при любом отёке или гиперемии расходится с возможностью амбулаторного лечения взрослых в стадии инфильтрации.
- Показания к хирургическому лечению сформулированы по-разному: в разделе 3.2 указаны абсцедирование и карбункул, в тезисе-рекомендации указано осложнённое течение, в критериях качества указана стадия абсцедирования.